

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

La hipertensión arterial se considera una enfermedad silenciosa porque la mayoría de personas no presentan síntomas, sin embargo, puede ocasionar daños cardíacos graves como la obstrucción y rotura de arterias. Aproximadamente 1400 millones de adultos de 30 a 79 años, hasta el 2024, padecen de hipertensión y se considera como una de las causas principales de muerte prematura en el mundo [1]. En Perú, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que entre el 20 % y el 40 % de la población adulta posee presión alta, además de ser más frecuentes en hombres (20.9%) que en mujeres (17.8%) y tener una mayor prevalencia en la costa (20.2%), por lo que es un grave problema de salud pública [2].

CAUSAS

Se asocia al consumo excesivo de grasas saturadas y trans, inactividad física, consumo de alcohol y tabaco como también antecedentes familiares [1].

CONSECUENCIAS

La hipertensión arterial provoca el daño progresivo de las arterias coronarias, debido a que el endotelio está expuesto al estrés mecánico que genera la alta presión arterial, por ende, favorece el desarrollo de aterosclerosis [3]. En el paciente hipertenso, el progreso de aterosclerosis con formación de placas que obstruyen las vías coronarias y la imposibilidad de aumentar el flujo sanguíneo cuando el miocardio necesita más oxígeno aumentan el riesgo de un episodio coronario [4]. Si se da una ruptura de placas, la presencia de dicha lesión ocasiona una angina de pecho, cuando la oclusión es parcial, o un infarto agudo del miocardio si la oclusión es total [5].

Asimismo, el corazón al bombear con mucha más fuerza para vencer la resistencia de las arterias, al igual que cualquier músculo sometido a esfuerzo excesivo, se agranda, condición conocida como hipertrofia ventricular izquierda. Ese tejido muscular engrosado y dañado es eléctricamente inestable, volviéndose altamente propenso a sufrir "cortocircuitos" severos, como la fibrilación ventricular. Esta arritmia es la que detiene el bombeo de sangre, provocando el paro cardíaco [6].

PROBLEMÁTICA

Un estudio poblacional coreano con más de 4 millones de personas encontró que quienes tenían hipertensión, presentaban un 65,4% más de riesgo de sufrir un paro cardíaco súbito respecto a la población no hipertenso [7]. Esta vulnerabilidad no desaparece tras el primer evento: un análisis del registro Oregon Sudden Unexpected Death Study, que siguió a 6,649 personas durante 18 años, encontró que la hipertensión arterial fue significativamente más prevalente entre los sobrevivientes que sufrieron un segundo paro cardíaco (69%) que entre quienes tuvieron solo un episodio (43%) [8]. Por ello, se suele recetar fármacos potentes (betabloqueantes y antiarrítmicos) para calmar el sistema eléctrico del corazón y reducir drásticamente la presión arterial. Sin embargo, sus efectos secundarios son persistentes como la bradicardia y la hipotensión. También se reportan fatiga, mareos, náuseas y

estreñimiento y pueden inducir hiperglucemia y enmascarar los signos hemodinámicos que suelen observarse en un paciente hipoglucémico, como la taquicardia [9].

Si bien es cierto, no existen estudios peruanos que analicen a profundidad el seguimiento al control y monitoreo, de la población específica de hipertensos, luego de haber sufrido su primer paro cardíaco, es posible construir una inferencia lógica. La población hipertensa peruana muestra una adherencia terapéutica deficiente, solo el 39,5% de los pacientes recibía tratamiento farmacológico, y únicamente el 14% de ellos mantenía la presión arterial controlada [10]. En base a que tanto la población hipertensa general y los sobrevivientes de paro cardíaco comparten que su hipertensión es no controlada y no existe evidencia de que haber sobrevivido a un evento cardíaco grave modifique por sí solo estos patrones de abandono terapéutico, es razonable inferir que una proporción similar de sobrevivientes peruanos de un primer paro cardíaco enfrenta el mismo riesgo de discontinuar su tratamiento antihipertensivo y de permanecer sin vigilancia adecuada frente a un segundo evento.

Se concluye que la deficiente adherencia terapéutica de la población hipertensa peruana, sumada a la ausencia de monitoreo continuo post-evento, perpetúa un ciclo de vulnerabilidad que incrementa significativamente el riesgo de un segundo paro cardíaco.

Referencias

- [1] Organización Mundial de la Salud, «Hipertensión». OMS. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>
- [2] Ministerio de Salud, «Más de cinco millones de peruanos sufren de hipertensión arterial y la mitad no lo sabe». MINSA, 16 de mayo de 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1168973-mas-de-cinco-millones-de-peruanos-sufren-de-hipertension-arterial-y-la-mitad-no-lo-sabe>
- [3] Lahera, Vicente, «Hipertensión y arteriosclerosis: relación entre el perfil circadiano de la presión arterial y el grosor íntima-media carotídeo», vol. 21, n.º 23-24, 2009.
- [4] Mayo Clinic, «Síndrome coronario agudo - Síntomas y causas». Mayo Clinic. [En línea]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/acute-coronary-syndrome/symptoms-causes/syc-20352136>
- [5] Clínica Universidad de Navarra, «Arteriosclerosis». [En línea]. Disponible en: <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/arteriosclerosis>
- [6] Mayo Clinic, «Hipertrofia ventricular izquierda». [En línea]. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/left-ventricular-hypertrophy/symptoms-causes/syc-20374314>
- [7] Y. G. Kim *et al.*, «Hypertension and diabetes including their earlier stage are associated with increased risk of sudden cardiac arrest», *Sci. Rep.*, vol. 12, n.º 1, p. 12307, jul. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-16543-2.
- [8] E. P. Held, K. Reinier, H. Chugh, A. Uy-Evanado, J. Jui, y S. S. Chugh, «Recurrent Out-of-Hospital Sudden Cardiac Arrest: Prevalence and Clinical Factors», *Circ. Arrhythm. Electrophysiol.*, vol. 15, n.º 12, dic. 2022, doi: 10.1161/CIRCEP.122.011018.
- [9] Farzam, Khashayar y Jan, Amandeep, «Beta Blockers», en *StatPearls*, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. [En línea]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532906/>
- [10] J. Medina-Lezama *et al.*, «Prevalence and patterns of hypertension in Peruvian Andean Hispanics: the PREVENCIÓN study», *J. Am. Soc. Hypertens.*, vol. 1, n.º 3, pp. 216-225, may 2007, doi: 10.1016/j.jash.2007.02.003.

